



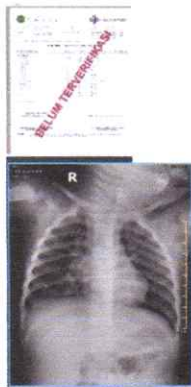
I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Ns. Eka Indah Restati, S.Kep
2	Nama Pasien	An. M ABDULLAH HABIBI (136902)
3	Unit Kerja yang terlibat	IGD
4	Tanggal Kejadian	19/01/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Bukti
19/1/2026	11.40	Pasien datang ke IGD dengan keluhan demam naik turun sejak 2 minggu terakhir, batuk berdahak kuning kehijauan, pasien sudah dibawa berobat ke faskes pertama tetapi keluhan belum membaik Tinggi Badan : 60 Berat Badan : 7,8 GCS : 15(Composmentis) : (E4V5M6) Tekanan Darah : 0/0 Nadi : 77 Respiration Rate : 30 Suhu : 38°C SpO2 : 90% (RA) Perawat IGD mengarahkan keluarga untuk daftar ke pendaftaran IGD	
	11.40	Pasien sudah didaftarkan dengan biling sementara UMUM karena semua pasien IGD masuk dengan biling UMUM terlebih dahulu	
	11.45	Dokter akbar memeriksa pasien dengan hasil : demam naik turun sejak 2 minggu terakhir, demam naik pada malam hari, keluhan disertai napas grok-grok, batuk berdahak kuning kehijauan, nafsu menyusu menurun, BAB BAK dbn, pasien sudah dibawa berobat ke faskes pertama tetapi keluhan belum membaik Riwayat Kesehatan : Kejang demam disangkal Riwayat Penggunaan Obat : Puyer Riwayat Alergi : Tidak Ada Pemeriksaan Fisik Kepala : a/i/c/d -/-/+ P.KGB (-)	



		Thorax : C/s1/s2 single m (-) g (-) P/ves D/S rhonki - - wh - - + + - - + + - - Abdomen : Soefl, BU (+) Normal NT -/-/- -/-/- -/-/- hepar lien ttb Ekstremitas : AHKM +/+, CRT<2s oedem -/- Lain-lain : - Diagnosis Utama : Obs Dyspneu susp BP dd TB Paru Pemeriksaan Penunjang Laboratorium : Darah Lengkap Rencana Terapi dan Tindakan O2 NC 2 lpm IVFD D5 1/4 250 cc/24 jam Inj. Santagesik 100 mg Inj. Ranitidin 10 mg	
	12.00	Perawat IGD memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan advice dr IGD	
	13.33	Hasil lab dan pemeriksaan thorax selesai	
	13.35	Dokter IGD mengirimkan konsulan ke dr. Qashas Sp.A	
	16.18	Dr. Qashas Sp.A membalas dan memberikan advice : Rujuk Pro HCU anak	



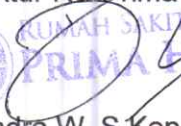
	16.20	Staff IGD tidak konfirmasi ke pendaftaran jika pasien rencana rujuk menggunakan BPJS, sehingga billing pasien tetap UMUM	
	06.37	Pasien diterima rujuk di RSUD bangil, namun pendaftaran tidak bisa mengeluarkan SEP rujuk	

III. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Pasien tidak bisa berangkat rujuk tepat waktu
2. Klaim terganggu
3. Total jumlah kerugian Rp. 987.000

IV. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
*Kepala Keuangan RS		
*Kabid Pelayanan Medik	1. Lakukan petergaan sesuai SOP. 2. Proses cetak SEP sesuai tanggal hari ini sebelum pasien berangkat ke RSUD Bangil	20/26/26 Yg up sisa.
*Kabid Umum Keperawatan	1. Koordinasi dan komunikasi antar unit tidak dilakukan 2. Proses sesuai ketentuan	20/26 Jk wulan
*Kabid Penunjang Medik	1. Cetak SEP rujuk 2. PPJA wajib memahami dan mengawal pasien 3. proses sesuai ketentuan	20 T 26 fahar
*SDM RS	Proses sesuai dengan ketentuan.	21/26

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

PRIMA HUSADA
SUKOREJO
Heni Indra W, S.Kep.Ns.M.Kep

Pembuat Kronologi

Nurul Karima

Catatan Direktur : Pasien yang datang ada rencana rujuk dari awal dan memiliki BPJS maka didaftar sebagai BPJS rawat jalan